Obstrucción intestinal e íleo

SEMIOLOGIA · Clase 32 · íleo mecánico, íleo paralítico y sus causas

1 · QUÉ ES Y CÓMO SE CLASIFICA

Obstrucción intestinal F6
interrupción del tránsito de sólidos, líquidos y gases

se ordena mediante la

Clasificación F6
alta o baja · aguda o crónica · total o parcial · mecánica o paralítica

si hay un obstáculo es el

si no hay obstáculo es el

Íleo mecánico
un obstáculo físico cierra la luz y el intestino lucha contra él

Íleo paralítico o adinámico
se inhibe la motilidad sin obstáculo mecánico

2 · CAUSAS DEL ÍLEO MECÁNICO

Bridas posquirúrgicas F2
secuela de laparotomías previas: la causa más frecuente

es la más frecuente de las

Tres causas más frecuentes F2 · F10
bridas o adherencias 35 % · hernias 25 % · tumores 16 %

le siguen en frecuencia

Le siguen F10
vólvulo de sigmoides 4 % e invaginación intestinal 4 %

incluyen el

e incluyen la

Vólvulo de sigmoides F13
dolicomegacolon o megacolon chagásico; obstrucción baja con gran distensión

Invaginación F8
menores de 2 años; la más frecuente es la ileocecocólica (🛍️ literatura)

son el obstáculo del

inhiben la motilidad y dan

con daño vascular es

también cierra la luz y produce el

se manifiesta por la

se manifiesta por la

3 · CLÍNICA DEL ÍLEO MECÁNICO

Tríada de síntomas F11
dolor cólico, vómitos y falta de eliminación de gases y heces

al examen se acompaña de la

su dolor es el

si el obstáculo es alto

si el obstáculo es bajo

Tríada de signos F11
distensión, ruidos hidroaéreos alterados y deshidratación

Cólico mecánico
dura 30 s a pocos minutos, cada 3-6 min

Obstrucción alta F9
vómitos precoces y abundantes, deshidratación rápida y poca distensión

Obstrucción baja F13
vómitos tardíos o ausentes y mucha distensión

causa obstrucción baja con

a la vez se auscultan los

con el tiempo cambia el

en etapas avanzadas pasa al

si hay un asa fija se palpa el

orienta la

con el tiempo cambia el

el nivel y el tiempo orientan la

Signo de von Wahl (🛍️) F4
asa distendida, fija y timpánica antes del obstáculo

Ruidos de lucha F7
metálicos y coincidentes con el cólico

Evolución del vómito
bilioso → oscuro → fecaloideo

y a veces se ven las

Ondas peristálticas visibles F7
peristaltismo de lucha: el signo propio de la obstrucción mecánica

al estimular la pared se llama

orienta la

Signo de Schlange (🛍️) F14
ondas peristálticas al estimular la pared

se estudia con la

4 · ESTRANGULACIÓN E ÍLEO PARALÍTICO

Íleo simple
no compromete la irrigación del asa

Causas intraabdominales F12
irritación peritoneal, posoperatorio de 24-72 h, pancreatitis, peritonitis, trombosis mesentérica

se distingue en la

Causas extraabdominales F12
hemorragia, infección retroperitoneal, cólico nefrítico, uremia, sepsis o lesión medular

sin daño vascular es

Íleo estrangulante
el asa pierde su riego: isquemia y necrosis; dolor continuo y distensión creciente

la necrosis lleva a la

Perforación y peritonitis

Silencio tardío
se agrega un íleo paralítico secundario; no descarta la obstrucción mecánica

se parece por eso a la

Clínica paralítica F1 · F5
dolor continuo, distensión sin ondas y silencio desde el inicio

5 · CÓMO SE ESTUDIA Y QUÉ SE HACE

Radiografía simple de pie
examen de elección: niveles hidroaéreos, pila de monedas y ausencia de gas distal

Laboratorio
leucocitosis y hematocrito alto por hemoconcentración; electrolitos y gases si hay deshidratación

orienta la

completa la

la deshidratación se valora con el

se distingue en la

Interpretación
distingue simple, estrangulante y paralítico

determina la

Conducta urgente
reponer líquidos y electrolitos; si hay estrangulación o peritonitis, cirugía inmediata

por su riesgo exige la

síndrome · concepto · mecanismo · causa · signo · síntoma · complicación · diagnóstico · desenlace · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Tu teoría: 09g Síndromes obstructivos y 09a (vómitos alto vs. bajo) — teoría del docente; 🛍️ von Wahl, Schlange e invaginación ileocecocólica